

LUIZ PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA

HD: AOS + Obesidade

MEDICO:

MEDICAMENTOS:

IMC

CIRCUNF. DE PESCOÇO

PA:

OXIMETRIA:

~~23~~ P = 15 (início 8cm H₂O)

~~11~~ IAH = 10.8 / e

~~21~~ m. de uso: 4h 28'

fua

~~14/12~~ P = 14.1

~~21~~ IAH = 4.5

m. de uso: 5h 10'

fua

~~18/01~~ P = 14.0 (9 / 16cm H₂O)

~~22~~ IAH = 3.7

m. de uso: 4h 25'

Fuga = 16.2

fua

~~14/05~~ P = 12.

~~22~~ IAH = 2.3

m. de uso: 4h 23'

fua

~~18/07~~ P = 12.9 / Bonif₂O

~~22~~ IAH = 1.9 / e

m. de uso: 5h 45'

Fuga = 7.1 l/min

~~25/09~~ P = 12.4 cm H₂O

~~23~~ IAH = 1.0

m. de uso: 5h 50'

fua

04/12/24 $P = 9,8 \text{ au H}_2\text{O}$ (mediana)

IAH = 1,9 c/h

mdi erro: 5h 5'

puça: 0,4 l/m

* troca filtro

* troca máscara

* troca aparelho pois
estava apresentando erro

Natacha

Descrição do Exame de Polissonografia POLISSONOGRAMA BASAL

Nome: **LUIZ PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA**

Sexo: **Masculino**

Idade: **69 anos**

IMC: **37,04**

Peso: **120 kg**

Altura: **180 cm**

Data: **23-09-2021**

Médico Solicitante: **BENEDICTO RUI JUNIOR**

Comentários:

Exame realizado em Laboratório do Sono, em boas condições técnicas paciente em sono espontâneo noturno.

Os parâmetros foram registrado no sistema Brain Wave II (NeuroVirtual)*, utilizando os registros de EEG: F4-M1, C4-M1, O2-M1, F3-M2, C3-M2, O1-M2; EOG: bilateral; EMG: mentoniano/submentoniano; EMG: tibial bilateral; ECG: montagem D2 modificada; fluxo aéreo nasal por cânula de pressão e oronasal por termistor; esforço respiratório torácico e abdominal; saturação da oxi-hemoglobina (SpO2) por oximetria de pulso; sensor de ronco (microfone); posição corporal no leito.

Análise do exame foi realizada segundo a padronização do Manual da Academia Americana de Medicina do Sono 2012. (AAMS).

Exame iniciado 22h:15m:57s horas e concluído 03h:10m:12s horas. A latência para início do sono foi de 6,5 minutos e a latência para o sono REM foi de 92,0 minutos. O tempo total de sono foi de 269,4 minutos, com eficiência do sono (TTS / TTR)* de 58,6%. A distribuição do sono mostrou: 4,1% de estágio N1, 71,7% de estágio N2, 14,0% de estágio N3 e 10,2% de sono REM. No período total de sono permaneceu 104,9 minutos em vigília.

Ocorreram 86 despertares breves tendo o índice de (19,2/hora).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0/hora.

* (Classif. Patológica dos Movimentos Periódicos de Pernas - Walters e cols 1995; Leve: 5 a 24/hora; Moderado: 25 a 49/hora; Grave: > 50/hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 84,4, a maior de 88 e a menor de 60.

O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 81,5/h.

O índice de apneia/hipopneia foi de 81,5/h sendo 3,0 apneia/hora e 78,5 hipopneia/hora.

O número total de eventos respiratórios foi de 214, sendo 206 hipopneias, 8 apnéias obstrutivas, 0 apnéias centrais e 0 apnéias mistas e 0 RERAS.

O tempo médio das apnéias foi de 22,1 segundos, com duração máxima de 37,5 segundos.

A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 91%, sendo a saturação média de 91% e a mínima de 67%.

(*) TTS ⇒ Tempo Total de Sono TTR ⇒ Tempo Total de Registro

Descrição do Exame de Polissonografia POLISSONOGRAMA CPAP

Nome: **Luiz Paulo Monteiro de Oliveira**

Sexo: **Masculino**

Idade: **69 anos**

IMC: **37,04**

Peso: **120**

Altura: **180**

Data: **24-09-2021**

Médico Solicitante: **Benedicto Rui**

Comentários:

Exame realizado em Laboratório do Sono, em boas condições técnicas paciente em sono espontâneo noturno.

Os parâmetros foram registrados no sistema Brain Wave II (NeuroVirtual)®, utilizando os registros de EEG: F4-M1, C4-M1, O2-M1, F3-M2, C3-M2, O1-M2; EOG: bilateral; EMG: mentoniano/submentoniano; EMG: tibial bilateral; ECG: montagem D2 modificada; fluxo aéreo nasal por cânula de pressão e oronasal por termistor; esforço respiratório torácico e abdominal; saturação da oxi-hemoglobina (SpO2) por oximetria de pulso; sensor de ronco (microfone); posição corporal no leito. Análise do exame foi realizada segundo a padronização do Manual da Academia Americana de Medicina do Sono 2012. (AAMS).

Exame iniciado 03h:15m:22s horas e concluído 06h:19m:57s horas. A latência para início do sono foi de 11,0 minutos e a latência para o sono REM foi de 110,0 minutos. O tempo total de sono foi de 184,6 minutos, com eficiência do sono (TTS / TTR)* de 58,1%. A distribuição do sono mostrou: 4,7% de estágio N1, 80,4% de estágio N2, 5,6% de estágio N3 e 9,3% de sono REM. No período total de sono permaneceu 66,1 minutos em vigília.

Ocorreram 32 despertares breves tendo o índice de (10,4/hora).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0/hora.
*(Classif. Patológica dos Movimentos Periódicos de Pernas - Walters e cols 1995; Leve: 5 a 24/hora; Moderado: 25 a 49/hora; Grave: > 50/hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 79,2, a maior de 82 e a menor de 59.

O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 37,6/h.

O índice de apneia/hipopneia foi de 37,6/h sendo 0,0 apneia/hora e 37,6 hipopneia/hora.

O número total de eventos respiratórios foi de 67, sendo 67 hipopneias, 0 apnéias obstrutivas, 0 apnéias centrais e 0 apnéias mistas e 0 RERAS.

O tempo médio das apnéias foi de 0,0 segundos, com duração máxima de 0 segundos.

A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 92%, sendo a saturação média de 92% e a mínima de 75%.

(*) TTS ⇒ Tempo Total de Sono

TTR ⇒ Tempo Total de Registro

Paciente: **Luiz Paulo Monteiro de Oliveira**
Data do Exame: **24-09-2021**